

D 嚢胞性腫瘍 cystic tumor

到達目標

- 嚢胞性腫瘍を列挙できる
- 嚢胞性腫瘍の好発部位を説明できる
- 嚢胞性腫瘍の画像診断と治療について説明できる

病因・病態・疫学

縦隔にみられる嚢胞性腫瘍として先天性、腫瘍性、炎症性が知られているが、主に先天性嚢胞について概説する。先天性嚢胞は真の腫瘍ではなく先天性形態異常である。先天性嚢胞は縦隔腫瘍の18～25%を占める¹⁾。頻度が多いのは前腸嚢胞 (foregut cyst)、心膜嚢胞 (pericardial cyst)、胸腺嚢胞 (thymic cyst) で、その他に嚢胞性奇形腫 (cystic teratoma)、胸管嚢胞 (thoracic duct cyst)、リンパ管腫 (lymphangioma)、髄膜瘤 (meningocele) などがある。前腸嚢胞は気管支原性嚢胞 (bronchogenic cyst) と食道重複嚢胞 (esophageal duplication cysts) からなり、ともに胎生期に前腸から発生する。前腸嚢胞は前腸由来の構造を含むことがあるため、組織学的に両者を明確に区別できないこともある。

a 前腸嚢胞

i) 気管支原性嚢胞

単房性で、気管気管支と索状に接続するが、内腔と気道の交通は通常認めない。嚢胞壁は線毛上皮で被覆され軟骨、平滑筋、気管支腺を認める。気管支腺分泌物を含んだ粘稠なクリーム状内容物を認めることが多い。半数以上は中縦隔に発生し傍気管、気管分岐部に多く、肺内に発生することもある。

ii) 食道重複嚢胞

食道重複嚢胞は食道嚢胞の中で一番多くみられ、嚢胞が食道壁内あるいは食道に接して存在し、嚢胞壁は2層の平滑筋層を有している。嚢胞内腔は線毛上皮や重層扁平上皮で被覆される。発生部位は下部食道レベルの右後縦隔が多い。

b 心膜嚢胞

薄壁性の嚢胞で心膜と索状に連結するが通常交通はない。心膜と交通を持つ場合は心膜憩室 (pericardial diverticle) と呼ばれる。発生部位は心横隔膜角で右側が多い。嚢胞壁は中皮で覆われ内容物は漿液性である。

c 胸腺嚢胞

通常前縦隔に発生する。先天性と後天性があり、先天性は単房性、後天性は多房性を呈することが多い。嚢胞壁は円柱上皮や立方上皮の他、重層扁平上皮に覆

われ内容物は漿液性である。後天性はHIV感染症やシェーグレン病などの自己免疫疾患での報告が多い。

症状・身体所見

無症状であることが多いが、周囲の臓器の圧迫による呼吸困難、嚥下障害、神経症状をきたすこともある。気管支原性嚢胞では感染を併発することがあり、発熱、咳嗽、膿性痰などを認めることがある。

診断・検査

多くは無症状であるため、胸部X線や胸部CTで見られることが多い。胸部CTで質的診断と占拠部位の診断を行う。造影CTやMRIが鑑別診断に有用である。良性の縦隔嚢胞は辺縁平滑で均一な厚みの壁を有し、円形もしくは楕円形を呈する。周囲構造への浸潤性発育は認めない。嚢胞内部のCT値が漿液性嚢胞では0～20 HU程度、粘稠度の高い液体が多い気管支原性嚢胞などでは20～40 HU程度を示すことが特徴的である。MRIでは液体成分を反映し、T2強調像で高信号を示すが、蛋白濃度が高度に上昇すると信号強度の低下がみられることがある。造影CTでは内部が造影されないことが特徴的である。

治療

一般的には症状を認める場合や明らかな増大を認める場合、分葉状の不整な形状や壁肥厚、壁在病変を伴い悪性が否定できない場合に積極的に外科的切除を考慮する。無症状の単房性の胸腺嚢胞、心膜嚢胞は経過観察されることが多い。気管支原性嚢胞では経過中に45%で症状を認め、0.7%で悪性所見を認めたとの報告もあり、早期に切除を勧める意見もあるが、緊密なフォローアップができれば経過観察も許容される²⁾。胸腔鏡下手術を行うことが多いが、気管支原性嚢胞では炎症による強い癒着を認めることがあり、胸腔鏡下手術や完全切除が困難なこともある。術中リスクが高いこともありうるので、事前に術式を含めよくカンファレンスで方針を検討し、十分なインフォームド・コンセントを行うことが大切である。

文献

- 1) McNamee CJ: Resection of benign anterior and middle mediastinal cysts and tumors, Adult Chest Surgery, 2nd Ed, Sugarbaker DJ, et al (eds), p1277-1286, McGraw-Hill, 2015
- 2) Kirmani B, et al: Interact Cardiovasc Thorac Surg 11: 649, 2010